

Y. BOUFLOUGHA¹, I. HOUAR¹, Y.O. DJEGHRI¹, K. BOUZENDA¹, DJ. BOUHSANE¹, E. MAHDJOUB¹

¹Service d'hémodiagnostic et transfusion sanguine CHU-Constantine

Introduction

La maladie de Klippel-Trenaunay (MKT) est une malformation congénitale complexe et rare associant une hypertrophie tissulaire, des malformations capillaires et des dysplasies veino-lymphatiques. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1900 par les médecins français Klippel et Trenaunay, puis, avec des caractéristiques cliniques similaires, par le dermatologue anglais Weber en 1907. Il a été désigné par le passé sous divers termes tels que syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (KTW), syndrome angio-ostéohypertrophique ou nævus, angiodyplasie congénitale ou malformation capillaire-lymphatique-veineuse (CLVM).
Au sein de ces vastes anomalies vasculaires, la stase sanguine peut induire une activation locale et chronique de la coagulation. Nous rapportons le cas d'un patient atteint de MKT ayant consulté au niveau de l'unité d'hémostase du CHUC, pour des rectorragies et des hématomes au niveau des membres inférieurs.

Objectif

Sensibiliser aux complications hémorragiques et thrombotiques de la maladie de Klippel-Trenaunay, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration étroite entre l'unité d'hémostase et les services cliniques pour optimiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Observation

Clinique



Patient de 16 ans présente:

- Rectorragies
- Hématomes dans le membre inférieur
- Varicosité au niveau du pied et l'abdomen
- Hépatomégalie modéré
- Fièvre
- Pâleur cutanéomuqueuse
- Ictère
- Hématurie
- Antécédents de deux TVP

en faveur d'une hémolyse



Figure 1: présente des hématomes dans le membre inférieur gauche



Figure 2,3: présente d'une varicosité au niveau du pied et l'abdomen

Biologique



FNS	Thrombopénie
TP	Bas
TCA	Allongé
Fibrinogène	Diminué
D-Dimères	Elevés
Facteurs de coagulation	Diminuer
Bilan de thrombose	Normal

→ Le bilan biologique a révélé une coagulopathie de consommation localisée (CCL)

Examens complémentaires



Figure 4: Rectosigmoïdoscopie en faveur de néoformations vasculaires gauches anormales



Figure 5: Echo-Doppler hépatique montre une ectasie de tronc spléno-mésentérique de 25 cm

Discussion

Le MKT peut se compliquer de manifestations hémorragiques et thrombotiques en rapport avec ses malformations veineuses. La stase sanguine au sein de ces anomalies vasculaires entraîne une activation chronique de la coagulation et la formation de microthrombi, à l'origine d'une CCL caractérisée notamment par une élévation des D-dimères, une consommation du fibrinogène et une numération plaquettaire variable. Cette CCL explique l'association paradoxale d'un risque de thrombose et d'hémorragie.

Les hématomes et les rectorragies peuvent ainsi être mis en relation avec les anomalies vasculaires et la consommation locale des facteurs de coagulation. L'atteinte gastro-intestinale du MKT, notamment anorectale et colorectale, peut être responsable de rectorragies chroniques ou récidivantes et, plus rarement, d'hémorragies sévères.

Conclusion

Le MKT à atteinte vasculaire digestive expose à un double risque hémorragique et thrombotique, notamment dans le contexte d'une CCL. Les rectorragies peuvent révéler une atteinte anorectale ou colorectale et nécessitent une évaluation spécialisée. Une prise en charge multidisciplinaire, fondée sur l'évaluation du bilan d'hémostase, de l'extension des malformations et du risque thrombo-hémorragique, est indispensable. L'anticoagulation, lorsqu'elle est indiquée, doit être individualisée et étroitement surveillée afin de contrôler la CCL tout en limitant le risque hémorragique.

Référence

- Pavone P, Marino L, Cacciaguerra G, Di Nora A, Parano E, Musumeci G, Ruggieri M, Polizzi A, Falsaperla R. Klippel-Trenaunay Syndrome, Segmental/Focal Overgrowth Malformations: A Review. *Children (Basel)*. 2023;10(8):1421. Berry, S.A.; Peterson, C.; Mize, W.; Bloom, K.; Zachary, C.; Blasco, P.; Hunter, D. Klippel-Trenaunay syndrome. *Am. J. Med. Genet.* 1998, 79, 319–326.
- Ghahremani, G.G.; Kangarloo, H.; Volberg, F.; Meyers, M.A. Diffuse Cavernous Hemangioma of the Colon in the Klippel Trenaunay Syndrome.
- Wang Z, et al. Gastrointestinal involvement in Klippel-Trenaunay syndrome: pathophysiology, evaluation, and management. *World J Gastroenterol*. 2023;29(27):4259-4272. doi:10.3748/wjg.v29.i27.4259.
- Wang Z, et al. Klippel-Trenaunay syndrome with multiorgan vascular involvement and gastrointestinal bleeding: a case report and literature review. *Medicine (Baltimore)*. 2025;104. doi:10.1097/MD.00000000000041634.